

TEST

J1 examen blanc 2023

Navigation du test

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121																							

[Terminer le test...](#)

TEMPS RESTANT **2:29:13**

QUESTION 1

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Quels sont les symptômes en faveur d'une bronchite aiguë d'origine virale ?

- ☐ a. Catarrhe nasal
- ☐ b. Fièvre à 39,5°C
- ☐ c. Toux sèche quinteuse
- ☐ d. Douleurs thoraciques en point de côté
- ☐ e. Odynophagie

QUESTION 2

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Quels sont les virus les plus incriminés dans les bronchites aiguës virales de l'adulte ?

- ☐ a. Myxovirus influenzae
- ☐ b. Adénovirus
- ☐ c. Virus parainfluenzae
- ☐ d. Rhinovirus
- ☐ e. Virus respiratoire syncytial

QUESTION 3

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Suite à l'égorgeage de votre mouton lors de l'aid kbir, vous découvrez des larves hydatiques au niveau du foie. Votre conduite à tenir est de :

- ☐ a. Le donner à votre chien
- ☐ b. L'incinérer
- ☐ c. Le jeter dans les poubelles publiques
- ☐ d. L'enterrer à 2 m de profondeur
- ☐ e. Le bouillir pendant 15 minutes



QUESTION 4

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Sur un scanner cérébral, les signes directs évocateurs d'une thrombose veineuse cérébrale sont :

- ☐ a. Une hyperdensité spontanée d'un sinus veineux
- ☐ b. Un hématome extradural
- ☐ c. Un signe de la corde
- ☐ d. Le signe du delta
- ☐ e. Un œdème péri lésionnel

QUESTION 5

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Quel(s) sont le(s) signe(s) alarmant(s) devant une rhinopharyngite ? :

- ☐ a. Déshydratation
- ☐ b. Fièvre les trois premiers jours
- ☐ c. Persistance de l'obstruction nasale pendant 7 jours
- ☐ d. Diarrhée le troisième jour
- ☐ e. Audition fluctuante

QUESTION 6

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Quel(s) type(s) d'atteinte peut(peuvent) compliquer une rhinopharyngite de l'enfant ? :

- ☐ a. Convulsion hyperthermique
- ☐ b. Crise d'épilepsie
- ☐ c. Éthmoïdite aiguë
- ☐ d. Torticolis fébrile
- ☐ e. Otite moyenne aiguë

QUESTION 7

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Quelle(s) est(sont) l'(les) affirmation(s) exacte(s) concernant la laryngite aigue sous glottique de l'enfant ? :

- ☐ a. le début est brutal
- ☐ b. Une hypersialorrhée est souvent présente
- ☐ c. le fièvre est élevée à 39-40°
- ☐ d. la voix est rauque
- ☐ e. le traitement se base sur une corticothérapie à forte dose par voie générale

QUESTION 8

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Quelles sont les bactéries qui peuvent être responsables d'emblée d'une bronchite bactérienne ?

- ☐ a. Haemophilus influenzae
- ☐ b. Mycoplasme pneumoniae
- ☐ c. Klebsiella pneumoniae
- ☐ d. Chlamydia pneumoniae
- ☐ e. Streptococcus pneumoniae

QUESTION 9

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Quelles sont les causes les plus fréquentes d'occlusion mécanique du colon chez l'adulte? :

- ☐ a. Le volvulus du sigmoïde
- ☐ b. La sigmoïdite diverticulaire
- ☐ c. Le cancer du côlon
- ☐ d. La colite ischémique
- ☐ e. Hernie inguinale étranglée

QUESTION 10

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Quelles sont les complications locales les plus fréquente au décours d'une pneumonie communautaire ?

- ☐ a. Abscess du poumon
- ☐ b. Fistulisation pleuro-pariétale
- ☐ c. Endocardite
- ☐ d. Pleurésie purulente
- ☐ e. Abscess hépatique

QUESTION 11

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Quelles sont parmi ces propositions les signes de gravité d'une embolie pulmonaire ?:

- ☐ a. Age < 60 ans
- ☐ b. Tachycardie > 120 BPM
- ☐ c. Saturation O2 < 90%
- ☐ d. Elévation du NT proBNP
- ☐ e. Troponine positive

QUESTION 12

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Quelles sont, parmi les suivantes, les propositions justes:

- ☐ a. Le dépistage et l'exérèse des polypes adénomateux et villex sont la meilleure prévention actuelle du cancer recto-colique
- ☐ b. La majorité des cancers recto-coliques provient de la dégénérescence de polypes adénomateux
- ☐ c. L'âge moyen de la dégénérescence dans la polypose familiale diffuse est de 60 ans
- ☐ d. Après colectomie totale pour polypose familiale diffuse, le rectum restant doit être surveillé très régulièrement, pour possibilité de cancer rectal
- ☐ e. Le risque de cancer croit avec le nombre et la taille des adénomes



QUESTION 13

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Quels signes sont en faveur d'une anxiété de séparation physiologique :

- ☐ a. Son retentissement sur le fonctionnement familial
- ☐ b. Son retentissement sur l'insertion préscolaire
- ☐ c. Son apparition à 40 mois de vie
- ☐ d. Le caractère rapidement résolutif de sa détresse
- ☐ e. Sa disparition à 30 mois de vie

QUESTION 14

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Quels sont les facteurs de mauvais pronostic en cas de péritonite aigue généralisée:

- ☐ a. L'existence d'un œdème aigue du poumon sur la radiographie du thorax
- ☐ b. L'existence d'une perforation colique
- ☐ c. La présence d'une hyperleucocytose à 15000
- ☐ d. L'origine appendiculaire
- ☐ e. La survenue chez un sujet sur corticothérapie au long cours

QUESTION 15

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Quels sont les germes rencontrés dans les otites moyennes aigues chez l'enfant ? :

- ☐ a. Streptocoque pneumoniae
- ☐ b. Branhamella catarrhalis
- ☐ c. Haemophilus influenzae
- ☐ d. Streptocoque A
- ☐ e. Staphylocoque aureus

QUESTION 16

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Quels sont les réponses justes concernant le traitement des péritonites aiguës :

- ☐ a. Le traitement étiologique d'une péritonite d'origine diverticulaire repose sur la sigmoïdectomie avec anastomose colorectale immédiate
- ☐ b. Dès que le diagnostic est posé, une antibiothérapie probabiliste par voie intraveineuse doit être débutée
- ☐ c. La toilette péritonéale n'est pas indiquée dans les perforations ulcéreuses débutantes en l'absence de pus franc
- ☐ d. La voie laparoscopique est actuellement préconisée dans la perforation ulcéreuse
- ☐ e. Un traitement par des anti inflammatoires est indiquée dans les péritonites localisées

QUESTION 17

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Quels sont les réponses justes concernant les abcès du cul de sac de Douglas :

- ☐ a. Le toucher rectal est normal
- ☐ b. Peuvent compliquer le traitement chirurgical d'une appendicite aigue
- ☐ c. Il existe une défense abdominale généralisée à l'examen clinique
- ☐ d. La fièvre est souvent absente
- ☐ e. Des signes urinaires à type de dysurie et pollakiurie peuvent être révélateurs

QUESTION 18

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est(sont) celle(s) qui constitue(nt) un facteur de risque de la GEU :

- ☐ a. La contraception par une pilule œstro-progestative
- ☐ b. Le tabac
- ☐ c. Un antécédant d'appendicectomie
- ☐ d. La multiparité
- ☐ e. Les infections génitales hautes

QUESTION 19

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Parmi les signes d'appel suivants, le(s)quel(s) évoque(nt) un cancer du cavum :

- ☐ a. Une fièvre et des sueurs nocturnes
- ☐ b. Une diplopie
- ☐ c. Une névralgie sous orbitaire
- ☐ d. Une dysphonie
- ☐ e. Une épistaxis récidivante unilatérale

QUESTION 20

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Peut de manifester par une diarrhée chronique avec un syndrome de malabsorption :

- ☐ a. Une colonisation bactérienne chronique du grêle
- ☐ b. Une colite microscopique
- ☐ c. Une mucoviscidose
- ☐ d. Une giardiose
- ☐ e. Une maladie de Whipple

QUESTION 21

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Pour un adénocarcinome du lobe inférieur droit avec atteinte de l'éperon lobaire inférieur-lobaire moyenne prouvée histologiquement, sans atteinte médiastinale, avec un bilan d'extension négatif, chez un sujet sans contre-indication opératoire, le geste chirurgical proposé sera :

- ☐ a. Une bilobectomie
- ☐ b. Une culminectomie
- ☐ c. Une segmentectomie
- ☐ d. Une lobectomie supérieure
- ☐ e. Une Pneumonectomie droite

QUESTION 22

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Pour un adénocarcinome du lobe supérieur droit, la chirurgie est contre-indiquée en cas d'atteinte ganglionnaire :

- ☐ a. Sus-claviculaire
- ☐ b. Interlobaire
- ☐ c. Hilaire
- ☐ d. Médiastinale homolatérale
- ☐ e. Axillaire

QUESTION 23

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Pour un adénocarcinome du lobe supérieur gauche avec envahissement scissural, sans atteinte médiastinale, avec un bilan d'extension négatif, chez un sujet sans contre-indication opératoire, le geste chirurgical proposé sera :

- ☐ a. Une Pneumonectomie
- ☐ b. Une lobectomie supérieure
- ☐ c. Une bilobectomie
- ☐ d. Une segmentectomie
- ☐ e. Une culminectomie

QUESTION 24

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Quel (s) geste (s) peut-on réaliser pour traiter une lithiase de la voie biliaire principale ?

- ☐ a. Cholangiographie peropératoire
- ☐ b. Echo-endoscopie
- ☐ c. Cholédocotomie
- ☐ d. Bili-IRM
- ☐ e. CPRE

QUESTION 25

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Quel (s) signe (s) clinique (s) évoque (nt) une angiocholite aigue ?

- ☐ a. Signe de Murphy
- ☐ b. Douleur de l'hypocondre droit
- ☐ c. Slénomégalie
- ☐ d. Fièvre
- ☐ e. Ictère

QUESTION 26

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Quel antituberculeux peut induire une carence en vitamine B6 ?

- ☐ a. Ethionamide
- ☐ b. Streptomycine
- ☐ c. Ethambutol
- ☐ d. Isoniazide
- ☐ e. Rifampicine

QUESTION 27

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Quel est le germe le plus fréquemment en cause dans les laryngites aigues sous glottiques de l'enfant ? :

- ☐ a. Haemophilus influenzae du groupe B
- ☐ b. Virus parainfluenzae
- ☐ c. Pseudomonas aeruginosa
- ☐ d. staphylocoque aureus
- ☐ e. Branhamella catarrhalis

QUESTION 28

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Quel(s) élément(s) caractérise(nt) les fausses membranes de la diphtérie :

- ☐ a. Saignantes
- ☐ b. Non reproductibles
- ☐ c. D'aspect blanc nacré
- ☐ d. Limitées aux loges amygdaliennes
- ☐ e. Adhérentes

QUESTION 29

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Quel(s) élément(s) caractérise(nt) les fausses membranes de la mononucléose infectieuse ? :

- ☐ a. Adhérentes
- ☐ b. D'aspect blanc nacré
- ☐ c. Non reproductibles
- ☐ d. Saignantes
- ☐ e. Limitées aux loges amygdaliennes

QUESTION 30

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Quel(s) est(sont) le(les) signe(s) clinique(s) en faveur d'une sinusite sphénoïdale ? :

- ☐ a. Cacosmie
- ☐ b. Céphalées profondes
- ☐ c. Rhinorrhée antérieure
- ☐ d. Trismus
- ☐ e. Douleur sous orbitaire

QUESTION 31

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Quel(s) est(sont), parmi les caractères suivants, celui(ceux) qui est(sont) en faveur de l'étiologie bactérienne d'une angine érythémateuse ? :

- ☐ a. fièvre élevée
- ☐ b. Douleur pharyngée intense
- ☐ c. trachéo-bronchite associée
- ☐ d. adénopathie sous-angulo-maxillaire
- ☐ e. Rhinorrhée et obstruction nasale

QUESTION 32

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Outre le traitement pharmacologique, la prise en charge de la maladie asthmatique comporte :

- ☐ a. L'éviction de tout activité sportive intense
- ☐ b. La prise en charge des comorbidités
- ☐ c. La vaccination anti pneumococcique annuelle
- ☐ d. L'incitation à l'arrêt du tabagisme
- ☐ e. L'éviction des allergènes indépendamment de l'étiologie de l'asthme

QUESTION 33

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Parmi ces complications du cancer du côlon sigmoïde, quelle est la plus fréquente:

- ☐ a. Fistule colo-vésicale
- ☐ b. Perforation tumorale
- ☐ c. Occlusion intestinale aiguë
- ☐ d. Perforation diastatique
- ☐ e. Absès péri-sigmoïdien

QUESTION 34

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Parmi les affections suivantes, citer celle(s) qui est (sont) responsable(s) d'une occlusion inflammatoire :

- ☐ a. Iléus biliaire
- ☐ b. Cholécystite lithiasique
- ☐ c. Péritonite appendiculaire
- ☐ d. Sigmöidite diverticulaire
- ☐ e. Colique néphrétique

QUESTION 35

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Parmi les causes des états confusionnels :

- ☐ a. Hydrocéphalie à pression normale
- ☐ b. Le sevrage alcoolique
- ☐ c. Les conversions hystériques
- ☐ d. Cécité brutale
- ☐ e. Douleurs aiguës

QUESTION 36

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Parmi les causes suivantes d'occlusion par strangulation, quelle (s) est (sont) celle (s) qui est (sont) exactes ?:

- ☐ a. Invagination intestinale aiguë
- ☐ b. Iléus biliaire
- ☐ c. Volvulus sur bride
- ☐ d. Maladie de Crohn
- ☐ e. Hernie inguinale étranglée

QUESTION 37

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Parmi les diagnostics suivants, lesquels peuvent mimer la maladie asthmatique? :

- ☐ a. Une pneumopathie infiltrante diffuse.
- ☐ b. Des dilatations des bronches.
- ☐ c. Une insuffisance cardiaque.
- ☐ d. Une masse médiastinale.
- ☐ e. Une inhalation de corps étranger.

QUESTION 38

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Parmi les éléments suivants, lesquels orientent vers l'étiologie allergique de l'asthme ? :

- ☐ a. Un eczéma associé.
- ☐ b. Des symptômes respiratoires à l'effort.
- ☐ c. Une intolérance à l'aspirine.
- ☐ d. Un asthme allergique aux acariens chez l'un des parents.
- ☐ e. Un trouble ventilatoire obstructif réversible.

QUESTION 39

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Parmi les éléments suivants, quels arguments cliniques orientent vers le diagnostic d'asthme? :

- ☐ a. Des symptômes déclenchés par l'exposition aux irritants.
- ☐ b. Les antécédents familiaux d'atopie.
- ☐ c. Des symptômes variables dans le temps.
- ☐ d. L'orthopnée.
- ☐ e. La présence d'une rhinite.

QUESTION 40

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Parmi les étiologies de la confusion mentale :

- ☐ a. La privation de sommeil
- ☐ b. La dépression du sujet âgé
- ☐ c. Un traumatisme psychique intense
- ☐ d. Le délire paranoïde
- ☐ e. L'amnésie dissociative

QUESTION 41

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Parmi les facteurs favorisant la survenue d'un cancer broncho-pulmonaire, on peut citer :

- ☐ a. Les séquelles pleuro-pulmonaires
- ☐ b. La silicose
- ☐ c. L'exposition aux poussières de maison
- ☐ d. La fibrose pulmonaire
- ☐ e. L'insuffisance respiratoire chronique

QUESTION 42

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Parmi les facteurs suivants quels sont ceux qui participent à l'obstruction bronchique au cours de la BPCO ? :

- ☐ a. L'inflammation bronchique
- ☐ b. La diminution des forces de rétraction élastique du poumon
- ☐ c. L'hypersécrétion de mucus
- ☐ d. L'épaississement pariétal bronchique
- ☐ e. L'hyperréactivité bronchique non spécifique

QUESTION 43

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Parmi les germes suivants, quels sont ceux qui sont fréquemment responsables d'exacerbation aigue de BPCO ?

- ☐ a. streptocoque alpha hémolytique
- ☐ b. Pseudomonas Aeroginosa
- ☐ c. Hémophilus influenzae
- ☐ d. Klebsiella pneumonia
- ☐ e. Branahmella cattarhalis

QUESTION 44

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Parmi les maladies suivantes, laquelle(lesquelles) est(sont) responsable(s) d'une ulcération amygdalienne unilatérale ? :

- ☐ a. Syphilis
- ☐ b. Diphtérie
- ☐ c. Angine de Vincent
- ☐ d. Scarlatine
- ☐ e. Carcinome amygdalien

QUESTION 45

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Parmi les maladies suivantes, laquelle(lesquelles) favorise(nt) les sinusites aiguës récidivantes de l'adulte ? :

- ☐ a. Sarcoïdose
- ☐ b. SIDA
- ☐ c. syndrome de Kartagener
- ☐ d. mucoviscidose
- ☐ e. Polypose naso-sinusienne

QUESTION 46

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Parmi les médicaments suivants, quels sont ceux qui peuvent être incriminés dans la survenue d'une maladie veineuse thromboembolique :

- ☐ a. Diane®
- ☐ b. Thalidomide
- ☐ c. Aspirine®
- ☐ d. Prednisone
- ☐ e. Tamoxifène

QUESTION 47

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Parmi les propositions suivantes concernant le traitement chirurgical d'un cancer du sigmoïde quelle(s) est(sont) celle(s) qui est(sont) adaptée(s) :

- ☐ a. Une résection segmentaire basse
- ☐ b. Une recto-sigmoïdectomie
- ☐ c. Une hémicolectomie gauche
- ☐ d. Une iléo-transversostomie
- ☐ e. Une iléostomie

QUESTION 48

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Parmi les propositions suivantes, les facteurs de risque de la prééclampsie sont :

- ☐ a. Intervalle inter-génésique court
- ☐ b. Antécédents personnels d'HTA chronique
- ☐ c. Multiparité
- ☐ d. Le syndrome des anti-phospholipides
- ☐ e. Antécédents familiaux d'HTA chronique

QUESTION 49

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Les anomalies radiologiques évocatrices d'une tuberculose pulmonaire communes sont:

- ☐ a. Une opacité surmontée d'un niveau hydro-aérique siégeant au niveau du lobe supérieur droit
- ☐ b. Des hyperclaretés multiples au sein d'infiltrats bilatéraux
- ☐ c. Un syndrome bronchique
- ☐ d. Un infiltrat réticulo-nodulaire apical unilatéral
- ☐ e. Une opacité apicale, dense homogène, avec lyse de la 1ère côte

QUESTION 50

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Les cardiopathies emboligènes à risque embolique élevé son:

- ☐ a. Foramen ovale perméable
- ☐ b. Cardiomyopathie dilatée
- ☐ c. Rétrécissement aortique calcifié
- ☐ d. Prothèse valvulaire mécanique
- ☐ e. Infarctus du myocarde récent (< 4 semaines)

QUESTION 51

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Les céphalées de tension :

- ☐ a. S'associent à des nausées et des vomissements
- ☐ b. Sont de siège orbitaire
- ☐ c. Sont chroniques et permanentes
- ☐ d. Sont des céphalées primaires
- ☐ e. Sont associées à des troubles psychologiques

QUESTION 52

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Les contre-indications de la thrombolyse intraveineuse pour accident vasculaire cérébral ischémique sont :

- ☐ a. Traumatisme majeur épargnant la tête datant de 6 mois
- ☐ b. Dissection aortique
- ☐ c. Endocardite infectieuse
- ☐ d. Traitement par anti-vitamine K avec INR à 1,3
- ☐ e. Taux de plaquettes à 90 000/mm3

QUESTION 53

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Les délais de la coronarographie au cours du syndrome coronarien aigu sans sus-décalage persistant du segment ST sont de :

- ☐ a. 2 heures en cas de troponines élevées
- ☐ b. 24 heures en cas de tachycardie ventriculaire
- ☐ c. 2 heures en cas de sous décalage diffus du segment ST avec sus-décalage en aVR
- ☐ d. 72 heures en cas de score GRACE à 150
- ☐ e. 2 heures en cas d'œdème aigu des poumons

QUESTION 54

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Les examens biologiques utiles pour évaluer le retentissement d'une diarrhée chronique sécrétoire :

- ☐ a. Le dosage de la CRP
- ☐ b. fonction rénale (urée et creat)
- ☐ c. La cholestérolémie
- ☐ d. Ionogramme sanguin
- ☐ e. la gazométrie sanguine

QUESTION 55

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Les facteurs de risque d'évolution défavorable au cours de l'asthme de l'enfant d'âge scolaire sont :

- ☐ a. Consommation de BDCA à raison de 1 flacon/an
- ☐ b. Antécédents d'exacerbation ayant menacé le pronostic vital
- ☐ c. Allergie alimentaire confirmée chez un patient asthmatique
- ☐ d. Sevrage récent de corticoïdes par voie générale
- ☐ e. Pas de prise actuelle de CSI ou défaut d'observance

QUESTION 56

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Les facteurs de risque de récurrence d'un ulcère hémorragique sont :

- ☐ a. Le siège de l'ulcère en sous cardinal
- ☐ b. Age < 40 ans
- ☐ c. Le diamètre de l'ulcère > 20 mm
- ☐ d. Une hémorragie active en jet sur la fibroscopie initiale
- ☐ e. La présence d'un état de choc hémorragique à l'admission

QUESTION 57

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Les manifestations extra-thoraciques faisant suspecter le diagnostic d'un cancer broncho-pulmonaire sont :

- ☐ a. Un Syndrome de Schwartz-Barter
- ☐ b. Un flush syndrome (diarrhée et bouffées vasomotrices)
- ☐ c. Un hippocratisme digital
- ☐ d. Un syndrome de Cushing
- ☐ e. Une hématurie

QUESTION 58

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Les perturbations engendrées par un syndrome occlusif secondaire à une strangulation de la lumière intestinale sont :

- ☐ a. Une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle
- ☐ b. Un défaut d'absorption au niveau de l'anse occluse
- ☐ c. Une perte des électrolytes Cl^- , Na^+ , K^+
- ☐ d. Une ischémie de la paroi intestinale
- ☐ e. Une déshydratation intra-cellulaire

QUESTION 59

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Les principales étiologies des AVC hémorragiques chez le sujet jeune:

- ☐ a. Angiopathie amyloïde
- ☐ b. Angéites cérébrales
- ☐ c. Anomalies de l'hémostase :AVK
- ☐ d. Dissection carotidienne
- ☐ e. Malformations vasculaires

QUESTION 60

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Les troubles du sommeil observés dans le tableau habituel de la dépression de l'enfant:

- ☐ a. Somnambulisme
- ☐ b. Cauchemars
- ☐ c. Insomnie d'endormissement
- ☐ d. Réveil précoce
- ☐ e. Sommeil haché

QUESTION 61

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Les ulcères angio-térébrants responsables d'une hémorragie de grande abondance siègent au niveau de :

- ☐ a. la face antérieure du bulbe duodénal par érosion de l'artère gastro-duodénale
- ☐ b. la grande courbure gastrique par lésion de l'artère gastro-omental droite
- ☐ c. le bord supérieur du bulbe par lésion de l'artère gastrique droite
- ☐ d. la grosse tubérosité par lésion de l'artère oeso-cardio-tubérositaire
- ☐ e. la petite courbure gastrique par lésion de l'arcade artérielle de la petite courbure

QUESTION 62

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Concernant les inhibiteurs du récepteur P2Y12 plaquettaire au cours du syndrome coronarien aigu sans sus-décalage persistant du segment ST :

- ☐ a. Le prasugrel est contre-indiqué en cas d'antécédent d'accident vasculaire cérébral
- ☐ b. Une dose de charge doit être administrée systématiquement dès la suspicion diagnostique en association à l'aspirine
- ☐ c. Le clopidogrel doit être arrêté 5 jours au moins avant une chirurgie non urgente
- ☐ d. Le ticagrelor présente une fixation irréversible aux plaquettes
- ☐ e. Le clopidogrel en dose de charge présente un délai d'action de 30 minutes

QUESTION 63

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Dans le cadre de la prise en charge d'une hémorragie intracérébrale capsulo thalamique chez un patient de 80 ans avec un Glasgow à 14, on propose :

- ☐ a. Mise du patient en position demi assise
- ☐ b. Mise en place une sonde naso-gastrique
- ☐ c. Abaissement de la tension artérielle systolique à moins de 140 mm Hg
- ☐ d. Admission en réanimation
- ☐ e. Administration d'un traitement antiépileptique préventive

QUESTION 64

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Dans le cancer du sein :

- ☐ a. La tumeur est dite multicentrique si ≥ 2 foyers dans des quadrants différents
- ☐ b. Le carcinome in situ ne donne pas des métastases ganglionnaires
- ☐ c. Dans le carcinome in situ, la membrane basale est toujours intacte
- ☐ d. Nait à partir du revêtement épithélial des canaux et des lobules
- ☐ e. Les collecteurs lymphatiques se drainent vers les nœuds lymphatiques sous claviculaires

QUESTION 65

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Des troubles de sommeil sont observé dans le tableau habituel de la/du :

- ☐ a. Schizophrénie
- ☐ b. Trouble anxiété de séparation
- ☐ c. Trouble anxiété généralisée
- ☐ d. Dépression
- ☐ e. Trouble hyperactivité déficit de l'attention

QUESTION 66

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Devant un syndrome douloureux thoracique aigu, associé à des signes d'insuffisance cardiaque droite, vous évoquez le ou les diagnostic(s) suivant(s):

- ☐ a. Une tamponnade
- ☐ b. Un syndrome coronarien sans sus décalage du segment ST dans le territoire inférieur
- ☐ c. Embolie pulmonaire à faible risque
- ☐ d. Une pleurésie droite
- ☐ e. Une dissection de l'aorte

QUESTION 67

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Cas clinique

Mr A.S âgé de 52 ans, sans antécédents pathologiques notables, consulte pour un ictère évoluant d'un seul tenant depuis 2 mois dans un contexte d'altération de l'état général.

Il rapporte par ailleurs un prurit généralisé, l'émission d'urines foncées et de selles décolorées.

A l'examen :

T° 37,1°C, constantes hémodynamiques stables ; état général moyen.

Ictère cutanéomuqueux ; lésions de grattage ; légère sensibilité de l'épigastre.

Absence de viscéromégalie.

TR : selles décolorées.

A la biologie :

GB : 7800/mm³ ; Hb : 11g/dL (VGM : 87fl ; TCMH : 28pg) ; PQ : 352000/mm³ ; CRP : 28 m/L ; ASAT/ALAT : 1N ; PAL : 4N ; GGT : 5N ; BT/BC : 108/78 mg/L (N< 12mg/L) ; TP : 52% ; Glycémie à jeun : 2,5g/L (N<1,1g/L)

1/ Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui sont en faveur de la nature cholestatique de l'ictère ?

- ☐ a. Prurit
- ☐ b. Selles décolorées
- ☐ c. Hyperbilirubinémie à prédominance conjuguée
- ☐ d. Urines foncées
- ☐ e. TP spontanément bas

QUESTION 68

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

2/ En se basant sur les éléments clinico-biologiques, le diagnostic de cancer de la tête du pancréas est suspecté.

Quel(s) est(sont) le(s) élément(s) en faveur du diagnostic de cancer de la tête du pancréas?

- ☐ a. Le caractère indolent de l'ictère
- ☐ b. L'absence de vésicule biliaire palpable
- ☐ c. Le genre masculin
- ☐ d. L'origine cholestatique de l'ictère
- ☐ e. Une glycémie à jeun élevée

QUESTION 69

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

3/ Quel(s) est(sont) le(s) examen(s) à demander en première intention ?

- ☐ a. Echo-endoscopie bilio-pancréatique
- ☐ b. Bili-IRM
- ☐ c. Scanner thoraco-abdominopelvien
- ☐ d. Bilan hépatique complet
- ☐ e. Echographie abdominale

QUESTION 70

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Cas clinique

Une patiente âgée de 30 ans consulte pour un AgHBs positif découvert il y a 8 mois. L'examen physique est normal.

A la biologie : ALAT= 90UI/l, ASAT= 80UI/l, Bilirubine totale= 12 μ mol/L, PAL= 50UI/l (VN <98), GGT= 30 UI/l (VN <38), Albumine= 42 g/l, Le TP= 80%, Hémoglobine= 13g/dl, Globules Blancs= 6700/mm³, Plaquettes= 255000/mm³. La sérologie virale B : AgHBs (+), AntiHBc IgG (+), AgHBe (-), AntiHBe (+), Anti VHC (-), Anti VHD (-). La charge virale du VHB positive à 5000UI/l.

L'échographie abdominale est normale. La détermination de l'élasticité par fibroscan : 10 KPA

1/ Le diagnostic retenu est :

- ☐ a. Une hépatite chronique B à virus mutant
- ☐ b. Une hépatite aigue B non sévère
- ☐ c. Une hépatite chronique B à virus sauvage
- ☐ d. Une hépatite aigue B sévère
- ☐ e. Une surinfection D chez un porteur chronique du virus B

QUESTION 71

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

2/ Le traitement de cette hépatopathie :

- ☐ a. Repose sur l'Entécavir au long cours
- ☐ b. Repose sur l'Entécavir pendant 48 semaines
- ☐ c. Repose sur par l'association Sofosbuvir – lédipasvir ou Sofosbuvir – Ribavirine pendant 12 semaines
- ☐ d. Ne sera indiqué qu'après la détermination du génotype viral
- ☐ e. Ne sera indiqué qu'après la réalisation d'une biopsie hépatique

QUESTION 72

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

3/ L'époux de cette patiente a un AgHBs(-) AntiHBc IgG(+) AntiHBs(+)

Concernant l'époux de cette patiente :

- ☐ a. Il a une hépatite B guérie
- ☐ b. Il a une hépatite chronique B
- ☐ c. Il a une hépatite aiguë B
- ☐ d. Il a été vacciné contre le virus de l'hépatite B
- ☐ e. Il doit être vacciné pour prévenir la transmission sexuelle du virus B

QUESTION 73

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Cas clinique :

Femme de 64 ans est adressée par son médecin rhumatologue pour exploration d'un nodule pulmonaire découvert sur une TDM thoracique faite dans le cadre de sa maladie (polyarthrite rhumatoïde).

A l'interrogatoire, on trouve un tabagisme actif à 20PA, un carcinome mammaire opéré il y a 6 ans avec une chimio-radiothérapie.

Elle ne rapporte pas de plainte en dehors d'une toux avec des expectorations depuis des années.

L'examen pleuro- pulmonaire est normal, la palpation des seins ne trouve pas de masse palpable et les aires ganglionnaires sont libres.

La radiographie thoracique montre une opacité nodulaire basale droite de contours spiculés.

La TDM thoracique montre un nodule pulmonaire sous pleural mesurant 19x18x16 mm de densité tissulaire et de contours irréguliers de la pyramide basale droite, pas d'adénopathies hilaires ni médiastinales.

Une fibroscopie bronchique est faite ne montrant pas de lésion endobronchique.

1/ Devant cette présentation vous évoquez :

- ☐ a. Un cancer pulmonaire primitif
- ☐ b. Un hamartochondrome
- ☐ c. Un nodule rhumatoïde
- ☐ d. Un tuberculome pulmonaire
- ☐ e. Une métastase pulmonaire d'un carcinome mammaire

QUESTION 74

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

2/ Pour avoir une confirmation diagnostique vous demandez :

- ☐ a. Les marqueurs tumoraux
- ☐ b. Une biopsie chirurgicale du nodule sous thoracoscopie
- ☐ c. Un TEP-scanner
- ☐ d. Une biopsie transpariétale du nodule sous contrôle scanographique
- ☐ e. Une biopsie par écho-transbronchique

QUESTION 75

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

3/ L'examen histologique des prélèvements biopsiques a montré une prolifération épithéliale maligne muco-sécrétante d'architecture glandulaire avec un stroma fibro-inflammatoire de moyenne abondance, exprimant à l'étude immunohistochimique le TTF1.

Quel est le type histologique de cette tumeur ?

- ☐ a. Adénocarcinome mammaire
- ☐ b. Adénocarcinome pulmonaire
- ☐ c. Carcinome pulmonaire à grandes cellules
- ☐ d. Carcinome épidermoïde du poumon
- ☐ e. Carcinome pulmonaire à petites cellules

QUESTION 76

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Cas clinique :

Madame AB âgée de 40 ans, groupe sanguin A négatif, vous consulte pour saignements vaginaux anormaux depuis trois jours.

Mme AB est diabétique type 1 depuis 20 ans bien équilibré sous insuline. G2P2, ayant eu deux accouchements par césarienne. Contraception actuelle par DIU.

La date des dernières règles remonte à 15 jours selon la patiente.

À l'examen : tension artérielle : 9/6 cmHg. Pouls 120 bpm, conjonctifs pâles.

L'examen au spéculum trouve un col sain, saignement rouge vif non abondant d'origine endo-utérine.

Au toucher vaginal : utérus il est de taille normal, cul-de-sac vaginaux libre, pas de masse latéro-utérine palpée.

1/ Madame AB se plaint de :

- ☐ a. Métrorragies
- ☐ b. Hémorragie génitale
- ☐ c. Hydrorrhée
- ☐ d. Leucorrhées
- ☐ e. Pyrométrie

QUESTION 77

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

2/ Quels éléments d'orientation diagnostique, doivent être recherchés par l'interrogatoire ?

- ☐ a. Notion d'infertilité
- ☐ b. Endométriose
- ☐ c. Un antécédent de MST
- ☐ d. Des antécédents de chirurgie pelvienne
- ☐ e. Tabagisme

QUESTION 78

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

3/ Les examens demandés ne sont pas concluants. Qu'est-ce que vous proposez ?

- ☐ a. Une cœlioscopie diagnostique
- ☐ b. Une antibiothérapie per os
- ☐ c. Des antalgiques en ambulatoire
- ☐ d. Une hospitalisation pour surveillance
- ☐ e. Adresser la patiente en gynécologie

QUESTION 79

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Cas clinique :

Madame M, âgée de 36 ans, enceinte à 24 SA, consulte pour des douleurs de l'hémi-abdomen droit.

A l'examen : Apyrétique, sensibilité du flanc droit.

A la biologie : GB : 14200 él /mm³ CRP 10 mg/l

Culot urinaire négatif

1/ Quels sont les diagnostics à évoquer :

- ☐ a. Appendicite aigue
- ☐ b. Cystite
- ☐ c. Pyélo néphrite aigue
- ☐ d. Cholécystite aigue
- ☐ e. Coliques néphrétiques

QUESTION 80

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

2/ Quel est le premier examen à demander :

- ☐ a. Echographie abdominale
- ☐ b. TDM abdominale
- ☐ c. Une uro graphie intra veineuse (UIV)
- ☐ d. IRM abdominale
- ☐ e. Radiographie du thorax centrée sur les coupes

QUESTION 81

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

3/ L'examen demandé montre une distension diffuse du grêle et du colon avec la présence d'une structure borgne en inter anse épaissie et épanchement de faible abondance en regard.

Quel diagnostic vous retenez ?

- ☐ a. Cholécystite aigue
- ☐ b. Pyélo néphrite aigue
- ☐ c. Appendicite aigue méso coeliaque
- ☐ d. Tumeur du grêle en occlusion
- ☐ e. Coliques néphrétiques hyper algiques

QUESTION 82

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Cas clinique :

Mm XY. est âgé de 67 ans, droitier, aux antécédents personnels d'hypertension artérielle et de diabète depuis 10 ans.

Il a présenté brutalement, à 07 heures du matin, une lourdeur du membre inferieur droit.

Il a consulté les urgences à 9heures du matin.

L'examen a objectivé une TA 180/100 mmHg, une température à 37°C ; une hémiplegie à prédominance crurale droite.

La glycémie au doigt était à 1,4 gramme/l.

La TDM cérébrale réalisée à 10H00 était normale

Le diagnostic d'accident vasculaire cérébral ischémique a été retenu.

1/ Quel est le territoire vasculaire touché ? :

- ☐ a. Le territoire superficiel de l'artère cérébrale moyenne gauche
- ☐ b. Le territoire total de l'artère cérébrale moyenne gauche
- ☐ c. Le territoire de l'artère cérébrale postérieure gauche
- ☐ d. Le territoire de l'artère cérébrale antérieure gauche
- ☐ e. Le territoire de l'artère choroidienne antérieure gauche

QUESTION 83

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

2/ Quelle est la conduite thérapeutique dans l'immédiat ? :

- ☐ a. La thrombolyse intraveineuse
- ☐ b. La prescription de Mannitol
- ☐ c. La prescription d'insuline rapide
- ☐ d. La perfusion de sérum glucosé
- ☐ e. Baisser la Tension artérielle

QUESTION 84

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

3/ Quels sont les examens complémentaires à demander dans ce cas :

- ☐ a. Ponction lombaire
- ☐ b. Bilan biologique
- ☐ c. IRM cérébrale
- ☐ d. Aucun examen ne sera demandé
- ☐ e. Biopsie des artères temporales

QUESTION 85

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Cas clinique :

Monsieur ZA, âgée de 37 ans, aux antécédents de rhumatisme articulaire aigu dans l'enfance et suivie pour une sinusite chronique, consulte le médecin de famille pour une fièvre.

il se plaint aussi d'arthralgies et d'asthénie et rapporte des maux de gorge survenus dix jours auparavant.

Le médecin note une fièvre à 38°C et un souffle systolique au foyer mitral.

L'électrocardiogramme et la radiographie pulmonaire pratiqués sont normaux.

Le bilan biologique montre : des globules blancs à 18200/mm³ à prédominance polynucléaire neutrophile, une CRP à 180 mg/l, une vitesse de sédimentation à 142 à la 1ère heure, une hémoglobine à 10 g/dl et des antistreptolysines O (ASLO) à 980 U/ml.

Le médecin décide de lui prescrire de l'Amoxicilline 3 g par jour per os pendant 7 jours.

Cependant, au bout du 5ème jour de traitement, Monsieur ZA est transportée en urgence et opérée pour ischémie aiguë du membre inférieur droit.

1/ Quel diagnostic évoquez en premier chez ce patient :

- ☐ a. une endocardite infectieuse
- ☐ b. Une maladie de Buerger
- ☐ c. une FA emboligène
- ☐ d. une poussée de RAA
- ☐ e. une artériopathie oblitérante des membres inférieurs

QUESTION 86

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

2/ Parmi ces examens complémentaires, le(s)quel(s) est (sont) indiqué(s) en 1ère intention pour confirmer le diagnostic :

- ☐ a. Une échocardiographie transthoracique
- ☐ b. Le dosage des BNP
- ☐ c. Un coroscanner
- ☐ d. Une échocardiographie transoesophagienne
- ☐ e. Le dosage des D-Dimères

QUESTION 87

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

3/ A 3 mois de traitement par AVK, le patient consulte pour des ecchymoses étendues avec au bilan biologique un INR à 8.

Quel sera votre conduite à tenir :

- ☐ a. Renforcer la dose des AVK
- ☐ b. Arrêt AVK
- ☐ c. Remplacer les AVK par HNF
- ☐ d. Remplacer les AVK par HBPM
- ☐ e. Arrêt AVK et introduire immédiatement du Rivaroxaban

QUESTION 88

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Cas clinique :

Un homme âgé de 42 ans, transplanté rénal sous traitement immunosuppresseur, présente depuis 3 jours une toux sèche quinteuse associée à un catarrhe nasal, une odynophagie et des brûlures rétro-sternales dans un contexte d'une fébricule.

Il a pris par automédication un antitussif et un antipyrétique.

Depuis 24 heures, il présente des douleurs basithoraciques droites à type de point de côté avec des frissons intenses et une asthénie marquée.

A l'examen, il a une température à 39,5°C, une fréquence respiratoire à 32c/mn, une saturation périphérique en oxygène à 95% à l'air ambiant et une fréquence cardiaque à 125 bpm.

Le diagnostic de pneumopathie aiguë communautaire est évoqué chez ce patient.

1/ Quels sont les symptômes en faveur de ce diagnostic chez ce patient ?

- ☐ a. Douleurs thoraciques en point de côté
- ☐ b. Frissons et asthénie
- ☐ c. Fièvre à 39,5°C
- ☐ d. Toux sèche quinteuse
- ☐ e. Catarrhe nasal

QUESTION 89

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

2/ L'hospitalisation de ce patient est indiquée devant :

- ☐ a. La fièvre à 39,5°C
- ☐ b. L'âge à 42 ans
- ☐ c. Le terrain immunodéprimé
- ☐ d. La saturation périphérique en oxygène à 95%
- ☐ e. La fréquence respiratoire à 32c/mn

QUESTION 90

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

3/ Quelle antibiothérapie prescrivez-vous chez ce patient ?

- ☐ a. Clarithromycine
- ☐ b. Amoxicilline-acide clavulanique
- ☐ c. Pristinamycine
- ☐ d. Levofloxacin
- ☐ e. Métronidazole

QUESTION 91

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Cas clinique :

Un homme âgé de 45 ans, est hospitalisé pour bilan d'une fièvre évoluant depuis deux mois.

Il a comme principaux antécédents médicaux une cardiomyopathie obstructive à caractère familial. Il est porteur d'un stimulateur cardiaque endocavitaire depuis 5 ans.

L'interrogatoire permet de retrouver la notion de détartrage dentaire il y a deux mois.

L'histoire débute par l'instauration progressive d'une asthénie, d'une anorexie et d'un amaigrissement.

Secondairement, il apparaît une fièvre à 39°C à prédominance vespérale accompagnée de frissons, de sueurs et de myalgies.

L'examen clinique à l'admission note un amaigrissement de 17 kg. La température oscille entre 38,5 et 39°C.

Il existe un souffle systolique d'insuffisance mitrale évalué à 3/6, déjà connu et non modifié. Il n'y a pas de signe d'insuffisance cardiaque droite ou gauche.

L'examen pulmonaire est sans particularité.

L'examen cutané retrouve des cicatrices propres de plaies cutanées sur les mains et les avant-bras (blessures professionnelles).

L'examen dentaire ne retrouve pas de foyer infectieux apparent : de nombreuses dents sont porteuses de pansements dentaires. Il n'y a pas de caries visibles.

Le bilan biologique effectué à l'admission montre : — protéine C-réactive (CRP) 110 mg/L ; — fibrinogène 6,5 g/L ; — hémoglobine 9,8 g/dL ; — fonction rénale normale.

1/ Quelle hypothèse diagnostique formulez-vous :

- ☐ a. Un abcès dentaire
- ☐ b. Une tuberculose
- ☐ c. Une péricardite purulente
- ☐ d. Une endocardite infectieuse
- ☐ e. Une pathologie néoplasique

QUESTION 92

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

2/ Trois jours après l'admission, les hémocultures prélevées durant les premières 48 heures sont stériles et l'échocardiographie transœsophagienne ne montre pas d'image évocatrice de végétation ni sur les valves cardiaques ni sur les sondes du pacemaker.

La fraction d'éjection du ventricule gauche est estimée à 55 %.

Malgré cela, le diagnostic d'endocardite infectieuse à hémocultures négatives ou à germes difficilement cultivables est considéré comme le plus vraisemblable et il est décidé d'entreprendre une antibiothérapie adaptée à cette situation.

Quels autres signes cliniques recherchez-vous pour réconforter le diagnostic :

- ☐ a. Adénopathies sous maxillaires
- ☐ b. Purpura pétéchial
- ☐ c. Taches de Janeway
- ☐ d. Faux panaris
- ☐ e. Splénomégalie

QUESTION 93

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

3/ Quel Antibiothérapie empirique démarrez-vous en attendant le résultat des hémocultures (le patient n'est pas allergique à la pénicilline) :

- ☐ a. Vancomycine + gentamicine + Rifampicine
- ☐ b. Amoxicilline + gentamicine
- ☐ c. Vancomycine + gentamicine
- ☐ d. Ceftriaxone + gentamicine
- ☐ e. Amoxicilline + oxacilline + gentamicine

QUESTION 94

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Cas clinique :

Un homme de 55 ans présente depuis 3mois des rectorragies, accompagnées de ténesme et de faux besoins. Son état général est conservé. Le toucher rectal est normal. L'examen de l'abdomen ne montre pas de masse palpable.

Une rectosigmoïdoscopie montre une lésion bourgeonnante, irrégulière, saignant au contact, sur la face antérieure du rectum,

à 12 cm de la marge anale, de 3 cm de diamètre. Des biopsies sont pratiquées au niveau de cette lésion.

1/ Quel est le résultat anatomopathologique le plus probable de cette biopsie ? :

- ☐ a. Polype adénovilleux
- ☐ b. Adénocarcinome Lieberkühnien
- ☐ c. Adénocarcinome colloïde muqueux
- ☐ d. Sarcome
- ☐ e. Carcinome malpighien

QUESTION 95

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

2/ Le bilan préopératoire de ce malade comportera :

- ☐ a. Une artériographie mésentérique inférieure
- ☐ b. Un dosage antigènes carcino embryonnaires
- ☐ c. Une fibroscopie oeso-gastrique
- ☐ d. Une échographie hépatique
- ☐ e. Une coloscopie totale

QUESTION 96

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

3/ Quel traitement envisagez-vous :

- ☐ a. Intervention de Hartman
- ☐ b. Chirurgie limitée par rectotomie
- ☐ c. Radiothérapie de contact
- ☐ d. Résection antérieure du rectum
- ☐ e. Amputation abdomino-périnéale

QUESTION 97

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

4/ La surveillance ultérieure de ce patient comportera systématiquement :

- ☐ a. Coloscopie de contrôle
- ☐ b. Scanner pelvien
- ☐ c. Echographie hépatique
- ☐ d. Dosage de l'Alpha foeto-protéine
- ☐ e. Dosage de l'antigène carcino-embryonnaire

QUESTION 98

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Cas clinique :

Un homme de 71 ans, tabagique sevré, ancien mineur à la retraite, consulte pour une dyspnée d'aggravation progressive associée à des expectorations striées de sang et des céphalées évoluant depuis 1 mois.

L'examen physique objective :

Un PS à 2, un hippocratisme digital, une TA= 130/80 mmHg, une FR= 22 cyc/min, FC= 88 bt/min, un œdème du cou avec comblement des creux sus claviculaires, une cyanose du visage, une turgescence des veines jugulaires et des râles ronflants à l'auscultation pulmonaire.

Le reste de l'examen est sans particularités.

1/ Parmi les signes cliniques suivants, quels sont ceux qui constituent un élément pronostique dans ce cas :

- ☐ a. Le PS à 2
- ☐ b. L'hippocratisme digital
- ☐ c. Les expectorations striées de sang
- ☐ d. La dyspnée
- ☐ e. Le syndrome cave supérieur

QUESTION 99

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

2/ La radiographie du thorax a objectivé une opacité para trachéale droite dont les limites externes sont spiculées. Un cancer broncho-pulmonaire est suspecté.

Quel(s) est (sont) le(s) type(s) histologique(s) le(s) plus probable(s) devant cette présentation radio clinique ?

- ☐ a. Un carcinome à grandes cellules
- ☐ b. Une tumeur sarcomateuse
- ☐ c. Un adénocarcinome
- ☐ d. Un carcinome à petites cellules
- ☐ e. Un carcinome épidermoïde

QUESTION 100

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

3/ La fibroscopie bronchique a montré un bourgeon au niveau de la bronche lobaire supérieure droite non obstructif dont les biopsies confirment la nature carcinomateuse de la lésion.

Le bilan d'extension a montré un processus tumoral médiastino-pulmonaire du lobe supérieur droit faisant 46x38x22 mm avec envahissement de la veine cave supérieure, des adénopathies hilaires droites, sous carinaires et médiastinales antérieures et une lésion hépatique d'allure suspecte, absence d'autres lésions suspectes à l'étage abdominal et cérébral.

Comment classez-vous cette tumeur ?

- ☐ a. T4N3M1b
- ☐ b. T4N1M1b
- ☐ c. T2N2M0
- ☐ d. T3N2M1b
- ☐ e. T3N3M1a

QUESTION 101

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

4/ Quel(s) est (sont) les choix thérapeutiques que vous pouvez proposer chez ce patient :

- ☐ a. Chimio-radiothérapie curative
- ☐ b. Radiothérapie décompressive
- ☐ c. Chimiothérapie palliative
- ☐ d. Immunothérapie
- ☐ e. Thérapie ciblée

QUESTION 102

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Cas clinique :

Un nourrisson âgé de 6 mois sans antécédents ayant un bon développement psychomoteur initial.

Depuis un mois, il présente des épisodes brusques de flexion de la tête et du tronc avec une élévation des jambes et une contraction des bras de brève durée.

Ces épisodes se répètent en série surtout au réveil.

A l'interrogatoire, on trouve la notion de perte de la tenue de la tête et de la position assise.

L'examen général montre des taches cutanées hypochromiques.

Un syndrome de West est suspecté. Vous demandez un électroencéphalogramme (EEG).

1/ Les anomalies qui peuvent être observées à l'EEG intercritique sont? :

- ☐ a. Une désorganisation totale du tracé de fond
- ☐ b. Une photosensibilité
- ☐ c. Des pointes et des pointes-ondes asynchrones, diffuses et permanentes
- ☐ d. Des pointes centro-temporales lentes biphasiques
- ☐ e. Des pointe-ondes généralisées à 3 Hz

QUESTION 103

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

2/ L'étiologie la plus probable du syndrome de West chez ce patient est :

- ☐ a. Une infection post natale
- ☐ b. Une lésion cérébrale anoxo-ischémique
- ☐ c. Une hémorragie intra crânienne
- ☐ d. Une sclérose tubéreuse de Bourneville
- ☐ e. Une erreur innée du métabolisme

QUESTION 104

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Cas clinique

Un patient âgé de 35 ans, originaire de Siliana, consulte pour des douleurs thoraciques latéralisées à gauche, associées à une toux sèche. L'examen clinique trouve une diminution du murmure vésiculaire à gauche. Une Radiographie du thorax est pratiquée.

1/ Quel serait votre attitude en premier lieu ?



- ☐ a. Fibroscopie bronchique
- ☐ b. Ponction pleurale
- ☐ c. Echographie thoracique
- ☐ d. TDM thoracique
- ☐ e. IRM thoracique

QUESTION 105

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

2/ Les différents examens pratiqués concluent à un kyste hydatique, quel serait votre attitude thérapeutique :

- ☐ a. Hospitalisation
- ☐ b. Traitement antibiotique en premier
- ☐ c. Traitement chirurgical
- ☐ d. Drainage thoracique en premier
- ☐ e. Traitement antihelminthique en premier

QUESTION 106

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

3/ A la sortie du patient, quels mesures préconisez-vous pour éviter les récives :

- ☐ a. Lavage soigneux des mains
- ☐ b. Lavage soigneux des crudités
- ☐ c. Prescrire un traitement antihelminthique
- ☐ d. Proscrire l'ingestion d'abat
- ☐ e. Proscrire le contact avec les chiens

QUESTION 107

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Cas clinique :

Une fille âgée de 17 ans sans antécédents familiaux consulte suite à la survenue d'une crise épileptique tonico-clonique généralisée. A l'interrogatoire, on trouve la notion de secousses myocloniques survenant peu après le réveil avec parfois un lâchage des objets depuis l'âge de 12 ans.

Vous suspectez une épilepsie myoclonique juvénile.

1/ Les arguments en faveur de l'épilepsie myoclonique juvénile sont :

- ☐ a. Le sexe féminin
- ☐ b. Le début à l'adolescence
- ☐ c. L'absence d'antécédents familiaux
- ☐ d. La survenue de crises tonico-cloniques généralisées
- ☐ e. Les myoclonies matinales

QUESTION 108

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

2/ Les crises myocloniques dans le cadre de l'épilepsie myoclonique juvénile peuvent être favorisées par :

- ☐ a. L'exposition à une stimulation lumineuse intermittente
- ☐ b. Le manque de sommeil
- ☐ c. Le stress
- ☐ d. L'hyperventilation
- ☐ e. Les réveils brusques

QUESTION 109

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

3/ Vous demandez pour cette patiente un électroencéphalogramme (EEG).

Les anomalies observées à l'EEG intercritique sont:

- ☐ a. Des décharges de pointes ondes à 3 Hz
- ☐ b. Des ondes lentes focales
- ☐ c. Des pointe-ondes asynchrones, diffuses et permanentes
- ☐ d. Des polypointe-ondes généralisées
- ☐ e. Des pointes centro-temporales lentes biphasiques

QUESTION 110

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Cas clinique :

Un patient âgé de 22 ans suivi pour un diabète de type 1 consulte pour une diarrhée chronique faite de selles graisseuses associées à un syndrome anémique.

La fibroscopie digestive avec biopsies duodénales était l'examen complémentaire demandé en première intention.

1/ Le diagnostic d'une maladie cœliaque stade IV de Marsh était retenu devant un ou plusieurs parmi les signes histologiques suivants :

- ☐ a. Une atrophie villositaire totale
- ☐ b. Une hyperplasie des cryptes
- ☐ c. Une hyper éosinophilie intra épithéliale > 40/100 enterocytes
- ☐ d. Un infiltrat inflammatoire lympho plasmocytaire du chorion
- ☐ e. La présence de macrophage PAS positifs au niveau de l'épithélium

QUESTION 111

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

2/ En l'absence de suivi d'un régime sans gluten le patient aura un sur risque de :

- ☐ a. Un lymphome du grêle
- ☐ b. Une dermatite herpétiforme
- ☐ c. Un cancer colorectal
- ☐ d. Un lymphome ganglionnaire
- ☐ e. Ostéoporose

QUESTION 112

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Une crise d'hypertonie aiguë par fermeture de l'angle peut être déclenchée par :

- ☐ a. Une anesthésie générale
- ☐ b. Une forte hypermétropie
- ☐ c. Des médicaments parasympholytiques
- ☐ d. Un traumatisme oculaire perforant
- ☐ e. Le passage de l'obscurité à la lumière

QUESTION 113

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Une crise épileptique provoquée :

- ☐ a. Peut être secondaire à une hypoglycémie
- ☐ b. Peut-être secondaire à une anémie
- ☐ c. Survient au cours des 14 jours suivant un accident vasculaire cérébral
- ☐ d. Est secondaire à une agression aigue circonstancielle du système nerveux central
- ☐ e. Peut-être secondaire à une intoxication au monoxyde de carbone

QUESTION 114

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Une diarrhée chronique faites de 5 selles par 24 h, diurne, post prandiale précoce et contenant des aliments non digérés sans douleurs abdominales ni altération de l'état général et améliorées par les ralentisseurs du transit chez un patient âgé de 50 ans est probablement secondaire à :

- ☐ a. Une hyperthyroïdie
- ☐ b. Un syndrome de l'intestin irritable
- ☐ c. Une tumeur neuroendocrine digestive
- ☐ d. Une maladie coéliquaue
- ☐ e. Une colite maladie de crohn

QUESTION 115

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Une embolie pulmonaire à risque élevé de mortalité :

- ☐ a. Est responsable de décès dans < 3% des cas
- ☐ b. Est responsable d'une hypertension artérielle pulmonaire
- ☐ c. Peut être associée à une élévation des troponines
- ☐ d. Implique obligatoirement une dysfonction du ventricule droit
- ☐ e. Est caractérisée par une instabilité hémodynamique

QUESTION 116

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Une endocardite infectieuse doit être soupçonnée :

- ☐ a. En présence d'une insuffisance cardiaque fébrile
- ☐ b. En présence d'un souffle cardiaque avec hémoculture négative et bilan inflammatoire normal
- ☐ c. En présence d'une hémiplégie fébrile chez un sujet de 65 ans
- ☐ d. En présence d'une fièvre avec souffle cardiaque
- ☐ e. d'une fièvre cédant en moins de 4 jours d'antibiothérapie

QUESTION 117

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Une migraine sans aura est retenue devant les critères suivants :

- ☐ a. Des vomissements
- ☐ b. Des céphalées pulsatiles
- ☐ c. La récurrence des crises (>5 crises)
- ☐ d. Une durée des crises inférieure à 4 heures
- ☐ e. Des antécédents familiaux de migraine

QUESTION 118

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Une thrombose veineuse cérébrale peut se manifester par :

- ☐ a. Des céphalées chroniques
- ☐ b. Une aphasie
- ☐ c. Une hémiplégie
- ☐ d. Des troubles du comportement
- ☐ e. Une crise d'épilepsie focale

QUESTION 119

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Une tumeur de l'angle gauche du côlon peut envahir :

- ☐ a. Le mésocôlon transverse
- ☐ b. Les ganglions lymphatiques de l'arcade de Riolan
- ☐ c. Les ganglions situés à l'origine de la mésentérique inférieure
- ☐ d. La grande courbure gastrique
- ☐ e. Le duodénum

QUESTION 120

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Une tumeur maligne du cæcum peut envahir :

- ☐ a. L'estomac
- ☐ b. L'uretère droit
- ☐ c. Les ganglions lymphatiques à l'origine de l'artère mésentérique inférieure
- ☐ d. La valvule de Bauhin
- ☐ e. Les ganglions lymphatiques à l'origine de l'artère iléo-appendiculaire

QUESTION 121

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Vous traitez une patiente pour un premier épisode dépressif majeur en Février 2022.

Après une régression initiale totale des symptômes, elle consulte de nouveau avec tous les signes d'un épisode dépressif majeur en Juin 2022.

Comment qualifiez-vous son atteinte ?

- ☐ a. Il s'agit du même épisode dépressif unique
- ☐ b. Il s'agit d'un trouble dépressif récurrent
- ☐ c. Il s'agit d'une forme à cycles rapides
- ☐ d. Il s'agit d'une dépression chronique
- ☐ e. Il s'agit d'un trouble bipolaire type 2

Université de Tunis El Manar

Copyright © 2023 Université Virtuelle de Tunis. All Rights Reserved.

